

基礎研 レポート

昨年末に示された介護と福祉の 部会意見書を読み解く(中)

積み残された財政問題は？住宅型有料老人ホームのケアマネジメントを有料化

保険研究部 ヘルスケアリサーチセンター 上席研究員 三原 岳
(03)3512-1798 mihara@nli-research.co.jp

1——はじめに～昨年末の介護部会意見書に盛り込まれた財政問題は？～

3年に一度の制度改正に向けた社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）介護保険部会の意見書が2025年12月に公表された。意見書では様々な論点が網羅されており、3回シリーズの（上）では2040年の生産年齢人口の減少を見据え、中山間地域などにおけるサービス提供体制を維持するための方策として、「回数」をベースとした報酬制度の見直しなどの論点を考察した。

さらに、介護保険部会意見書では、前回の改正で積み残された3つの財政問題、すなわち（1）2割負担の対象者拡大、（2）ケアマネジメントの有料化、（3）要支援者の身体的自立を促す「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者拡大——についても、議論の経過や方向性が示された。

結論を先取りすると、1つ目と2つ目では具体的な提案が示され、2つ目では一部の住宅型有料老人ホームについて、ケアマネジメントを有料化することが決まった。しかし、1番目は2026年夏に先送りされ、3つ目の総合事業の対象者拡大は具体的な見直し案さえ示されなかった。

そこで、3回シリーズの（中）では3つの論点に関する経緯を振り返りつつ、意見書の内容を検討し、今後の論点や方向性を検討する。

なお、ほぼ同じタイミングでは社会保障審議会福祉部会でも意見書が公表されており、人材確保の部分では介護保険部会の意見書と共通している部分がある。このため、（下）では2つの部会文書にまたがって介護人材の記述ぶりを検討するほか、福祉部会の意見書に盛り込まれた論点も概観する。

2——なぜ財政問題が焦点になり続けるのか

1 | 給付費を巡る状況

まず、介護保険制度の財政問題が焦点になり続ける理由を考察する¹。2000年度にスタートした介護保険制度は高齢者の増加などに伴い、利用者負担を含む総費用が増えている。具体的には、スタート

¹ 介護保険が「財源」「人材」という2つの制約条件に直面している点については、2021年度制度改正から指摘している。過去の制度改正論議については、2023年1月12日拙稿「[次期介護保険制度改正に向けた審議会意見を読み解く](#)」のほか、「介護保険が直面する2つの制約条件」『生活協同組合研究』2022年7月号などを参照。2019年12月24日拙稿「[『小粒』に終わる？次期介護保険制度改正](#)」などを参照。今回の制度改正については、2025年7月29日拙稿「[介護保険改正の論点を考える](#)」を参照。

時は約 3 兆 6,000 億円だったが、2023 年度時点で約 11 兆 7,000 億円に膨らんでいる。

ただ、筆者自身としては、総費用の増加を「問題」と受け止めているわけではない。介護保険が創設された当時、在宅サービスが十分に普及しないまま、保険料の負担だけが先行する「保険あってサービスなし」の状態が懸念されていたことを考えると、「国民の間にサービスや制度が定着した」と評価することも可能である。

それでも公費（税金）や保険料の負担が増えているのは事実である。特に、ここでは介護保険の財政問題が焦点になり続ける理由として、(1) 高齢者の保険料負担の増加、(2) 現役世代の負担軽減を求める声、(3) 少子化対策の財源確保——という 3 つを挙げる。

2 | 給付費の削減が必要視される理由 (1) 高齢者の保険料増加

まず、65 歳以上の高齢者が支払う介護保険料の増加である。65 歳以上の高齢者に課されている介護保険料の月額平均基準額は 3 年ごとに変更されており、当初は 2,911 円でスタートしたが、直近の 2024 年～2026 年度は 6,225 円に増えている²。

しかも、この保険料は基礎年金からの天引きで徴収されており、基礎年金の月額平均支給額が約 5 万円であることを考えると、大幅な引き上げは困難である。このため、給付抑制の選択肢が議論されやすい状況となっている。

3 | 給付費の削減が必要視される理由 (2) 現役世代の社会保険料軽減

さらに、近年の国政選挙で話題になっている「現役世代の手取りを増やす」「社会保険料負担の軽減」という論点も介護保険の財政問題に繋がる。具体的には、40 歳以上 65 歳未満の介護保険料は 65 歳以上の高齢者の保険料と連動する仕組みになっており、制度創設時は 2,075 円だったが、2025 年度見込額で 6,202 円に伸びている。

特に昨年 10 月から連立政権に入った日本維新の会（以下、維新）は「社会保険料負担の軽減」を重視し、関連する制度の見直しを強く求めている³。どちらかと言うと、維新の主張の力点は医療費適正化に置かれているが、後述する通り、介護保険制度の見直しに関する提言を高市早苗首相に提出する一幕もあった。

4 | 給付費の削減が必要視される理由 (3) 少子化対策の財源確保

第 3 に、岸田文雄政権が重視した「次元の異なる少子化対策」の財源確保という側面である。出生数の低下に危機感を抱いた岸田政権は児童手当の大幅拡充などに取り組んだが、総額 3.6 兆円に及ぶ財源については「国民負担を増やさない」という方針を繰り返し表明した。

その結果、2023 年 12 月に決まった枠組みでは、既定予算の見直しで 1.5 兆円、歳出削減で 2.1 兆円を確保することが決まったほか、歳出削減のメニューが「全世代型社会保障構築を目指す改革の道

² 居住する市町村や所得に応じて、実際の保険料の負担は異なる。

³ 医療制度改革に関する維新の主張のうち、医療提供体制改革に関する動向については、2026 年 2 月 27 日拙稿「[臨時国会で成立した改正医療法で何がかわるのか（中）](#)」を参照。

筋（改革工程）」（以下、改革工程）で列挙された⁴。この後に触れる通り、改革工程に介護保険制度の見直しとして、2 割負担の対象者拡大などが言及されており、財源問題が議論の俎上に上る一つの要因となっている。

では、こういった流れの下、どんな制度改革が取り沙汰されてきたのだろうか。最近 2 回の制度改革論議では（1）2 割負担の対象者拡大、（2）ケアマネジメントの有料化、（3）要支援者の身体的自立を促す「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下、総合事業）の対象者拡大——という 3 つが焦点になったが、いずれも 2027 年度改正に結論が先送りされた。以下、その経緯と論点を簡単に取り上げる。

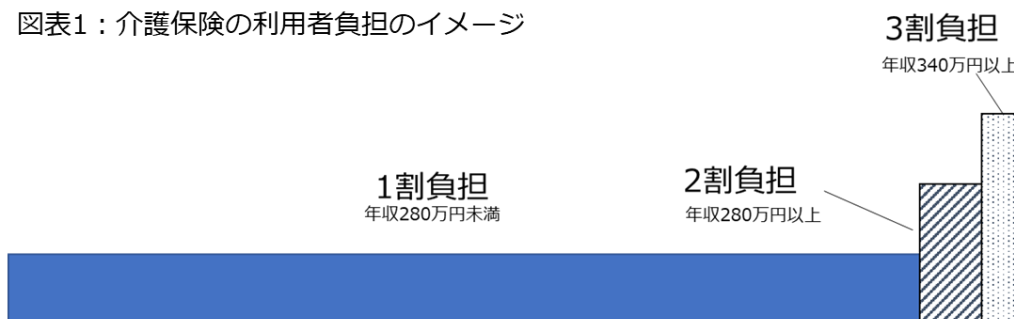
3——先送りされていた 3 つの問題を巡る経緯と論点

1 | 2 割負担の対象者拡大

まず、2 割負担の対象者拡大を巡る議論の経緯を整理する⁵。介護保険は制度創設時、所得に関わらず、利用者に 1 割の負担を求める

「応益負担」が採用されていたが、給付費を抑制する観点に立ち、2015 年度に 2 割負担、2018 年度に 3 割負

図表1：介護保険の利用者負担のイメージ



出典：厚生労働省資料を基に作成

担が導入された。それぞれを区分する収入基準は図表 1 の通り、年収 280 万円以上が 2 割、年収 340 万円以上が 3 割となっている。

ここで、2 割負担の線引きを引き下げると、2 割負担の対象者が広がり、その分だけ税金（公費）や保険料の負担を抑制できるため、財務省は前回の 2024 年度制度改革に際して、220 万円程度の引き下げを主張した。介護保険部会でも健康保険組合連合会（以下、健保連）は基準の引き下げを支持したが、業界団体や利用者の代表が反対し、意見が一致しなかった。

その後、厚生労働省は 2023 年 11 月、図表 2 のような資料を提出した。ここでは 280 万円の所得基準を 10 万円単位で引き下げた場合の選択肢として、「どれだけの人が影響を受けるか」「どれぐらいの給付抑制額になるか」という試算が示されていた。

ここで当時、筆者が注目したのは 190 万円までのシナリオが示された点である。つまり、財務省などが主張する 220 万円よりも低い水準が提示されていたことになる。厚生労働省としては、9 つの選択肢を示すことで、最終的に政治に判断を委ねたのであろう。

⁴ 少子化対策や改革工程の検討過程について、改革工程の内容については、2024 年 2 月 14 日拙稿「[2024 年度の社会保障予算の内容と過程を問う（下）](#)」、同月 1 日拙稿「[2024 年度の社会保障予算の内容と過程を問う（中）](#)」を参照。高額療養費の見直し過程については、2025 年 4 月 10 日拙稿「[異例づくめの高額療養費の見直し論議を検証する](#)」、同月 8 日拙稿「[政策形成の『L』と『R』で高額療養費の見直しを再考する](#)」を参照。

⁵ 2 割負担の対象者拡大を巡る論点などについては、2024 年 3 月 1 日拙稿「[介護保険の 2 割負担拡大、相次ぐ先送りの経緯と背景は？](#)」を参照。

言い換えると、介護保険部会の意見集約を諦めたと目された。実際、介護保険部会では、「もう部会では議論せずに予算編成に委ねる」ということはこの部会の存在意義が問われる（略）。極めて遺憾と言わざるを得ない」⁶との声が出ていた。

これに対し、元厚生労働相で自民党の田村憲久政調会長代行（当時、以下、肩書は全て同じ）は2023年11月の民放番組で、「広げたとしても、ホントに若干280万円から下がるぐらいの話」「220万円はかなり生活に影響が出る。我々はそれを反対」と述べた⁷。

その後、自民党旧安倍派を中心とするパーティー収入の不記載問題に対する世論の反発が広がったこともあり、結論は2027年度改正、つまり2025年から本格的に始まる論議に先送りされた。

図表2：介護保険部会に示された2割負担対象者拡大の選択肢

所得・収入基準の 選択肢	被保険者の 数	影響を受ける人数 (被保険者の数 ×16%)	給付抑制額の 見通し
単身270万円以上 2人以上336万円以上 (合計所得150万円以上)	62万人	8万人	▲90億円
単身260万円以上 2人以上326万円以上 (合計所得140万円以上)	130万人	17万人	▲180億円
単身250万円以上 2人以上316万円以上 (合計所得130万円以上)	200万人	27万人	▲280億円
単身240万円以上 2人以上306万円以上 (合計所得120万円以上)	270万人	36万人	▲380億円
単身230万円以上 2人以上296万円以上 (合計所得110万円以上)	340万人	45万人	▲480億円
単身220万円以上 2人以上286万円以上 (合計所得100万円以上)	410万人	54万人	▲580億円
単身210万円以上 2人以上276万円以上 (合計所得90万円以上)	470万人	62万人	▲660億円
単身200万円以上 2人以上266万円以上 (合計所得80万円以上)	520万人	69万人	▲740億円
単身190万円以上 2人以上256万円以上 (合計所得70万円以上)	570万人	75万人	▲800億円

出典：厚生労働省資料を基に作成

2 | ケアマネジメントの有料化

2つ目のケアマネジメント有料化も、以前からの懸案である⁸。介護サービスの調整などを担うケアマネジメントは創設時から「居宅介護支援費」という名称でサービスの一つに組み込まれるとともに、利用者負担を無料、つまり全額を保険給付で賄う形が取られた。これは当時、「従来の医療保険にはない事務的サービスの給付であり、利用者に費用負担の対価であるという認識を持ってもらうには時間を要するのではないかという配慮から、（略）利用者負担の対象外」⁹とされた。

しかし、財務省は2018年5月以降、有料化の必要性を主張し続けている。その内容は変遷をたどっているものの、▽有料化すれば、国や自治体の公費（税金）や保険料の負担軽減に繋がる、▽ケアマネジメントは相当程度、定着しており、特別扱いは不要、▽有料化すれば利用者の目が厳しくなるた

⁶ 2023年12月7日、介護保険部会議事録における健康保険組合連合会常務理事の伊藤悦郎委員の発言から引用。

⁷ 2023年11月30日放映のBS-TBS『報道1930』における発言。

⁸ ケアマネジメント有料化を巡る経緯や論点については、2025年12月12日拙稿「[三度目の正直？ケアマネジメント有料化論議の行方は](#)」、2022年9月28日拙稿「[居宅介護支援費の有料化は是か非か](#)」、2020年7月16日拙稿「[ケアプランの有料化で質は向上するのか](#)」を参照。なお、筆者はケアマネジメント有料化に明確に反対の立場だが、議論の経過に関わる整理と私見はできるだけ切り離して議論を進める。

⁹ 堤修三（2018）『社会保険の政策原理』国際商業出版 p241 を参照。

め、ケアマネジメントの質が上がる、▽特別養護老人ホーム（以下、特養）など施設系サービスではケアマネジメントが報酬に組み込まれており、別扱いとなっている在宅との均衡が保てない——という4つに整理できる。

これに対し、介護保険部会では健保連などが有料化を支持したが、業界団体や利用者代表から利用控えなどの懸念が示されるなど、意見対立は解消せず、2021年度、2024年度の改正で結論が先送りされ、決着は2027年度改正、つまり2025年から本格的に始まる論議に持ち越されていた。

3 | 総合事業の対象者拡大

3つ目の総合事業の対象者拡大も先送りされた案件である。[\(上\)](#)でも触れた通り、総合事業の仕組みは複雑であり、詳しい説明を避ける¹⁰が、要支援者の訪問介護の生活援助と通所介護（デイサービス）が給付から切り離され、従来の介護予防事業と統合された。さらに、保険者（保険制度の運営者）である市町村の判断で報酬や基準を決められるようになり、住民主体の体操教室やボランティア活動にも介護保険財源を充当することが認められた。

つまり、総合事業では身体的自立の改善の可能性が期待される要支援1～2の高齢者に対し、「地域の実情」に沿って、市町村が住民の互助活動やボランティアと連携して高齢者の外出機会を増やしつつ、身体的自立に繋がるリハビリテーションも強化することで、給付を抑制する意図が込められている。しかも、市町村に配分される総合事業の予算については、高齢化率の範囲内で上限が設定されているため、費用を制御しやすい。

そこで、財務省は給付抑制の観点に立ち、要介護1～2に対象を拡大することを要請したが、総合事業は市町村に浸透しておらず、2024年度改正に際しては、介護保険部会で慎重論が相次いだ。このため、2027年度制度改正に結論が先送りされていた。

以下、先送りされていた3つの財政問題について、2027年度改正に向けた財政制度等審議会（財務相の諮問機関、以下、財政審）や介護保険部会の議論の様子、同部会意見書の内容などを検討する。

4——先送りされていた3つの問題の推移（1）～2割負担の対象者拡大～

1 | 2割負担対象者拡大を巡る2つの提案

まず、2割負担対象者拡大について、財務省は2025年11月の財政審で、図表3の資料を示しつつ、2割負担の対象者拡大を改めて求めた。その際には「高齢者世帯の平均貯蓄額が増加傾向」「過去の負担引き上げでも、利用控えに与える影響は限定的」などと指摘し、一定程度の負担上限を設定したり、金融資産を考慮したりする可能性に言及しつつ、医療保険と同様の負担が望ましいとした。

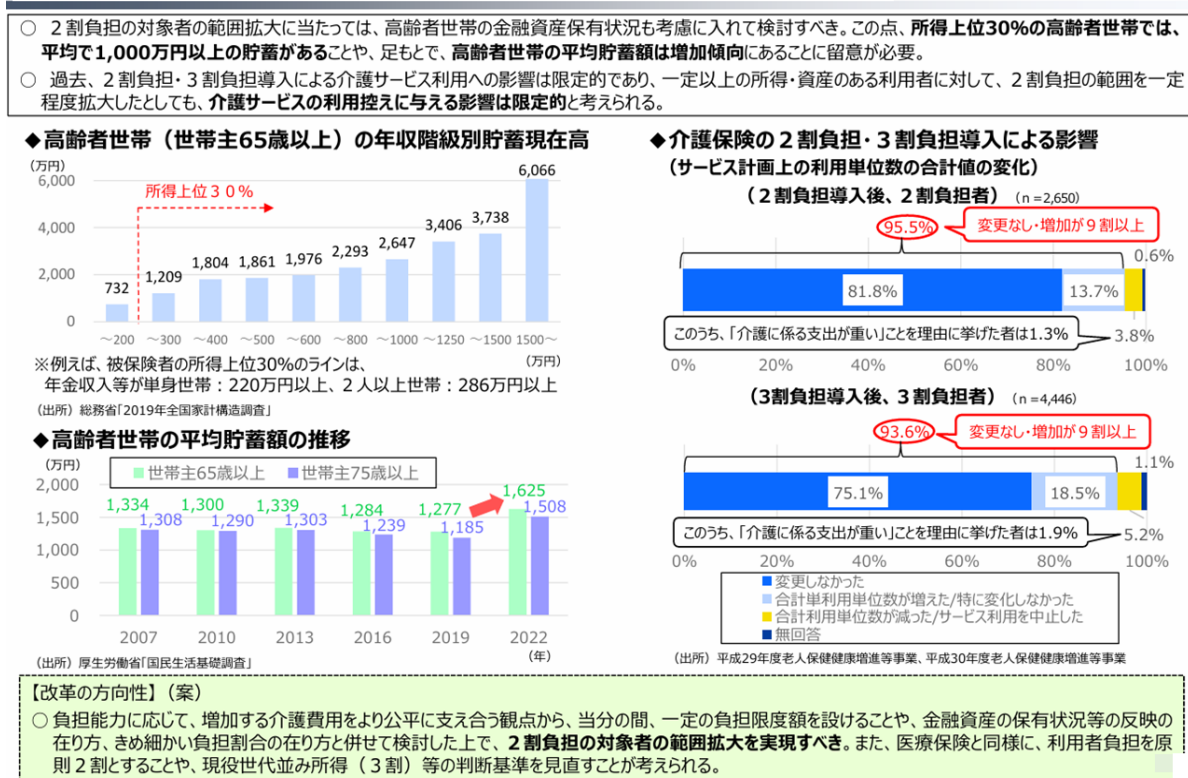
その後、厚生労働省は2025年12月の介護保険部会で、2割負担の対象者拡大に関する検討の方向性として、(1) 当分の間、一定の負担上限額を設ける、(2) 負担への金融資産の保有状況を反映する——という2つの配慮を講じる案が示された。これらは改革工程に盛り込まれていた文言¹¹に対応し

¹⁰ 総合事業では要支援者の身体的自立を促すため、3～6カ月間の集中的なリハビリテーションに加えて、外出機会を確保するための場づくりが重視されているが、多くの市町村では高齢者の暮らしを起点に考えず、総合事業のサービスメニューを揃えることに力点が置かれており、「地域の実情」に応じた施策が展開されているとは言い難い。総合事業の動向や内容や論点などに関しては、2023年12月27日拙稿「[介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か？](#)」を参照

¹¹ 改革工程では、2割負担の判断基準を引き下げる案に加えて、「当分の間、一定の負担上限額を設定」「介護保険における

ており、財政審での議論も意識されたとみられる。

図表3：2割負担の対象者拡大を求めた財務省の資料

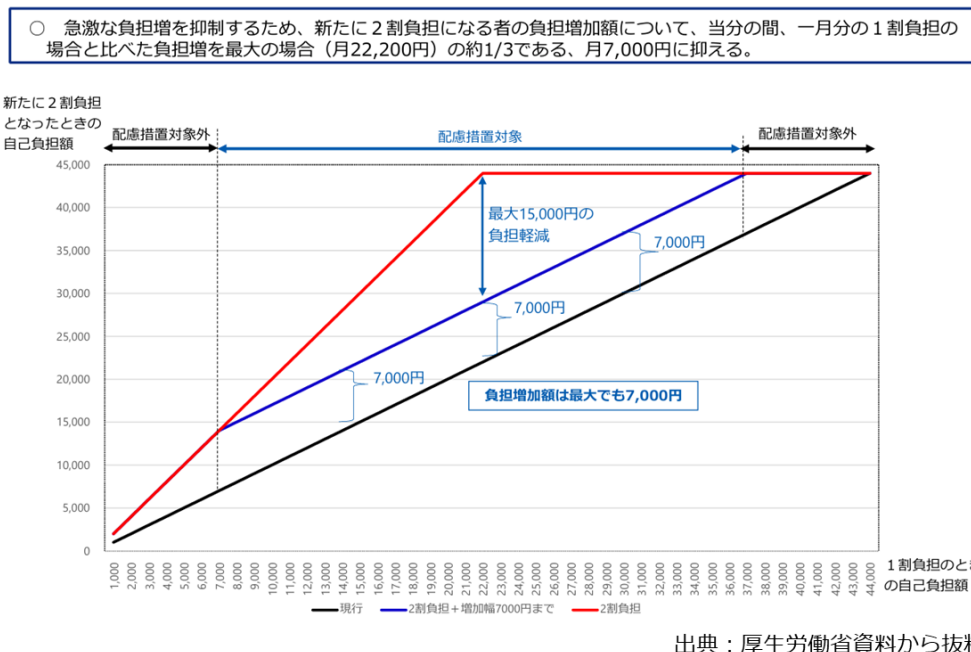


出典：財務省資料から抜粋

このうち、前者は図表4の通り、急激な負担増を抑制するため、月額で7,000円の上限を設定する案だった。

さらに、後者は金融資産の状況を考慮する狙いがあり、一定以下の預貯金を有していない利用者については、2割から1割に負担を下げる案である。

図表4：2割負担導入に際して上限を設定する配慮措置のイメージ



負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討開始」という文言が入っていた。

2 | 2割負担対象者拡大を巡る介護保険部会の議論

さらに、同年12月の介護保険部会では見直しに伴う影響の試算が公表された。これは2023年12月に示された図表2をベースにしつつ、2つの案を反映した場合、影響を受ける人数と給付抑制額が試算されている。

図表5：2割負担拡大の際、上限7,000円を設定した場合の試算

このうち、1つ目の案では図表5の通り、230万円～260万円まで10万円刻みの4区分で示され、影響を受ける人は13～35万人程度、給付抑制額は最大で210億円とされた。

所得・収入基準の 選択肢 (単身の場合)	見直しに伴う削減・抑制額（概数）			影響者数
	給付費削減の 合計額	削減額のうち、 保険料の抑制額	削減額のうち 国費の抑制額	
260万円以上	▲80億円	▲40億円	▲20億円	約13万人
250万円以上	▲120億円	▲60億円	▲30億円	約21万人
240万円以上	▲170億円	▲80億円	▲40億円	約28万人
230万円以上	▲210億円	▲100億円	▲50億円	約35万人

出典：厚生労働省資料を基に作成

一方、2つ目の案では図表6の通り、230万円～260万円まで10万円刻みの4区分について、預貯金で判断する基準の線引きとして、「単身で700万円、夫婦で1,700万円」「単身500万円、夫婦1,500万円」「単身300万円、夫婦1,300万円」の3つの選択肢が示された。さらに、12個に区分けされた影響も提示され、1割に戻る人の見通しは最小で約4万人、最大で約19万人、給付抑制額は80億～220億円とされた。

図表6：2割負担拡大の際、預貯金を反映した場合の試算

預貯金が単身700万円、夫婦1,700万円の場合

所得・収入基準の 選択肢 (単身の場合)	見直しに伴う削減・抑制額（概数）			影響者数	申請で 1割に 戻る人数
	給付費削減の 合計額	削減額のうち、 保険料の抑制額	削減額のうち 国費の抑制額		
260万円以上	▲80億円	▲40億円	▲20億円	約7万人	約6万人
250万円以上	▲110億円	▲60億円	▲30億円	約11万人	約10万人
240万円以上	▲140億円	▲70億円	▲40億円	約14万人	約14万人
230万円以上	▲170億円	▲80億円	▲40億円	約16万人	約19万人

預貯金が単身500万円、夫婦1,500万円の場合

所得・収入基準の 選択肢 (単身の場合)	見直しに伴う削減・抑制額（概数）			影響者数	申請で 1割に 戻る人数
	給付費削減の 合計額	削減額のうち、 保険料の抑制額	削減額のうち 国費の抑制額		
260万円以上	▲90億円	▲40億円	▲20億円	約8万人	約5万人
250万円以上	▲140億円	▲70億円	▲40億円	約13万人	約8万人
240万円以上	▲160億円	▲80億円	▲40億円	約16万人	約13万人
230万円以上	▲190億円	▲100億円	▲50億円	約19万人	約17万人

預貯金が単身300万円、夫婦1,300万円の場合

所得・収入基準の 選択肢 (単身の場合)	見直しに伴う削減・抑制額（概数）			影響者数	申請で 1割に 戻る人数
	給付費削減の 合計額	削減額のうち、 保険料の抑制額	削減額のうち 国費の抑制額		
260万円以上	▲90億円	▲50億円	▲20億円	約9万人	約4万人
250万円以上	▲140億円	▲70億円	▲40億円	約14万人	約7万人
240万円以上	▲190億円	▲90億円	▲50億円	約18万人	約10万人
230万円以上	▲220億円	▲110億円	▲60億円	約22万人	約14万人

出典：厚生労働省資料を基に作成

これらの数字を2023年12月の試算と比べると、配慮措置の結果、影響を受ける人は減少したが、給付抑制額の予想は約5～6割減となった。

これに対し、介護保険部会では再び意見が割れた。つまり、業界団体や利用者代表は利用控えなどを懸念したのに対し、健保連や日本経済団体連合会（以下、経団連）が負担増の案を支持する従来と同様の展開になった。

一方、配慮措置については、健保連と経団連の間で微妙な差異が見られた。具体的には、健保連は2つ目の案では「保険者の事務負担」が問題になるとしつつ、1つ目の上限設定の案が「現実的ではないか」と主張したのに対し、経団連は「負担能力に応じた負担という観点からすれば、預貯金等で資産の能力を勘案していくという方向が妥当」として2つ目の案を支持した¹²。

3 | 介護保険部会意見書の文言

結局、介護保険部会意見書では賛否両論が併記され、結論が先送りされた。具体的には、反対意見として、「物価高騰下で、高齢者の生活実態を踏まえれば、見直して良いかは慎重に検討すべき」「介護は医療と比べ、利用期間が長いと、利用者負担の増加は利用控えを招き、結果として重度化を招く」「(筆者注：上限7,000円の案でも)負担の上昇は重く、当分の間が終われば上昇が大きい」「(筆者注：預貯金を考慮する案は)網羅的な把握ができず、不公平感が残る」などの声を列挙。

一方、「医療との整合性、能力に応じた負担、保険料の上昇抑制の観点からなるべく多くの方が一定以上の所得の対象となるように要件を設定すべき」「現役世代の負担を考えれば、原則2割負担といった踏み込んだ検討も必要」「(筆者注：上限7,000円の案は)現実的な対応であり、これと組み合わせで基準の引下げを行うべき」「(筆者注：預貯金を考慮する案は)現在可能な手段で実施し、マイナンバー等の活用を進め、実施方法を改善していくべき」「(筆者注：預貯金を考慮する案の)範囲に生命保険の積立金を加えるべき」などの賛成意見も併記された。

さらに、結論を出す時期については、第10期介護保険事業計画期間の開始の前までに、結論を得る方向性が示された。ここで言う介護保険事業計画とは、3年周期で市町村が策定する計画を指しており、第10期とは2027年度から始まる次期計画を指す。

つまり、上記の文言は2027年4月の前に結論を出すという意味であり、現実的なシナリオとして、経済財政政策の方向性を定める「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太方針)が決まる2026年6~7月頃に一定程度の方向性が示されると思われる。

4 | 2つの提案に関する筆者の私見

またもや先送りされた背景などは後述するとして、ここでは2割負担の対象者拡大に関わる経過や結果について、私見を述べたい。

筆者自身、能力に応じた「応能負担」の強化は避けられない流れと考えており、利用者負担の増加は止むを得ないと考えている。今回の先送りについても、2つの具体的な提案が示された点で、単に遷延を繰り返してきた今までの流れとは一線を画しており、医療サービスとの違いを踏まえると、配慮措置を講じる案も合理的と言える。

しかし、厚生労働省から示された2つの提案を実行する上では、いくつかのハードルが横たわっている。まず、高齢者の患者負担引き上げ論議が影響する可能性がある。2025年10月の自民、維新連立合意では、2026年度中に結論を出す社会保障改革の一つとして、「医療費窓口負担に関する年齢に

¹² 健保連の伊藤悦郎常務理事、経団連の井上隆専務理事の発言。2025年12月15日、社会保障審議会介護保険部会議事録を参照。

よらない真に公平な応能負担の実現」という項目が入っており、原則 1～2 割と定められている高齢者の患者負担を引き上げる検討が始まる見通しだ。

特に、2025 年 12 月に公表された社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」では、2026 年度中に結論を出すテーマとして、現役並み所得を持つ人に限っている 3 割負担の対象者拡大が言及されており、こうした中で高齢者医療と介護の両面で負担を求めるのは難しい面がある。実際、介護保険部会意見書でも第 10 期介護保険事業計画の開始までに結論を得るという文章の前に、2026 年度に医療保険制度における給付と負担の見直しを踏まえる必要性が示唆された。

さらに、2 つ目の預貯金を考慮する案については、実行に向けた高いハードルが予想される。確かに金融資産を考慮する重要性は以前から論じられていたが、預貯金を考慮しつつ、2 割負担を 1 割負担に戻す事務作業は煩雑になると思われる。

実際、現在も特養など施設・住宅の入居者に関して、預貯金を考慮する仕組みが部分的に導入されているにもかかわらず、その実効性が問われていることは無視できない。これは「補足給付」と呼ばれる仕組みであり、仕組みが些か複雑なので簡単に整理する。

ここで言う補足給付とは、施行後 5 年に当たる最初の見直しになった 2005 年度に導入された仕組みであり、正式名称は「特定入所者介護サービス費」。在宅との均衡を図る観点に立ち、特養など施設の食費・居住費が保険給付の対象外、すなわち自己負担になったが、低所得者については、補足給付として引き続き介護保険財源から支出することにした。

その後、2015 年度改正の際、預貯金などが単身で 1,000 万円、夫婦世帯で 2,000 万円を超えている場合などについては、補足給付の対象外、つまり自己負担が徴収されることになった。

しかし、利用者に対する書類の提出要請や金融機関への照会、書類の内容確認などの事務が煩雑であり、現場では必ずしも厳格に運用されていない可能性がある。この点は今後、DX（デジタルトランスフォーメーション）で解消できる面があるとはいえ、現時点では制度を運用する際のボトルネックになる危険性があり、給付抑制を求める健保連でさえ難色を示した理由である。この点についても、介護保険部会で市町村の代表から「申請受付の同意書の確認、照会結果の突合、相違が生じた場合の説明や対応など、多くの作業が職員の手作業で発生してきます。（略）ぜひ正確性の担保と市町村の事務負担のバランスを考え、引き続き慎重に検討を進めていただきますようお願い申し上げます」¹³という意見が示された。

以上のような経緯を踏まえ、介護保険部会意見書でも今後の検討に際して、「現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等」を踏まえる必要性が言及されている。

5——先送りされていた 3 つの問題の内容（2）～ケアマネジメント有料化～

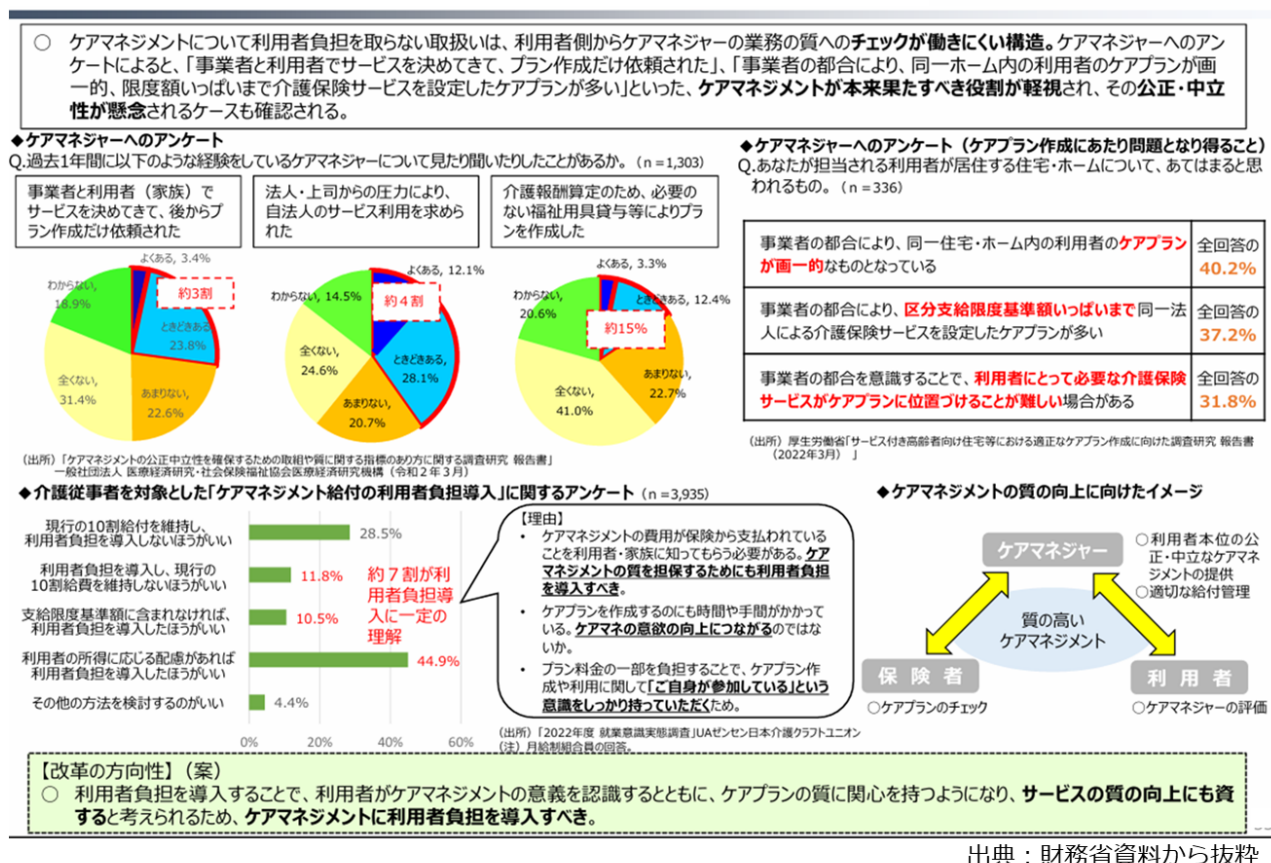
1 | 示された 3 つの提案

ケアマネジメント有料化についても、財務省が 2025 年 11 月の財政審で、図表 7 のような資料を提示しつつ、従来の主張を繰り返した。つまり、ケアマネジメントを有料化すれば、保険料や公費（税

¹³ 全国町村会行政委員を務める茨城県美浦村の中島栄村長の発言。2025 年 12 月 15 日、社会保障審議会介護保険部会議事録を参照。

金)の負担が減るほか、利用者の関心が高まるため、質が上がるといった主張である。

図表7：ケアマネジメント有料化を求めた財務省の資料



その後、厚生労働省は同月の介護保険部会で具体的な見直し案として、3つの選択肢を示した。すなわち、(1)利用者の所得状況を金額に反映させる案、(2)住宅型有料老人ホームの入居者を対象にする案、(3)給付管理業務の実費相当分を求める案——の3つである。

このうち、1つ目の案は他のサービスとの均衡を図るため、利用者負担を導入した上で、所得の低い利用者に対しては引き続き無料にしたり、利用者負担を減額したりする方法。これは財務省の主張を受け入れつつ、介護保険部会で示されている利用控えへの懸念に対応する意味合いがあり、言わば折衷案である。

2つ目については、住宅型有料老人ホームを舞台にした訪問看護の不適切とされる案件が絡む。この関係では、[\(上\)](#)で触れた通り、住宅型有料老人ホームに併設されている訪問看護事業所がサービスを過剰に提供している疑い、いわゆる「囲い込み」の案件が相次いで報じられており、適正化の側面を持っている¹⁴。2つ目の選択肢については、有料老人ホームに関わる報酬を説明する必要がある、有料化の狙いや論点は後述する。

第3の選択肢については、ケアマネジメント業務のうち、利用者の負担額などを計算する給付管理だけを有料化するアイデアである。この背景には、ケアマネジメントに従事するケアマネジャー（介

¹⁴ 有料老人ホームを舞台にした不適切とされる事案の構造や論点などについては、2025年8月27日と同年9月26日の拙稿「[相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は？](#)」（上）2回、リンク先は上）を参照。

護支援専門員)の人手不足が指摘されているため、ケアマネジャーの負担軽減の目的があったとみられる。さらに、厚生労働省は介護DXの一環として、ケアマネジャーが勤務する居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の情報をデジタルで繋ぐ「データ連携システム」を普及させようとしており、ケアマネジメントの有料化をテコにしつつ、デジタル化を進めたいという意図も読み取れた。

結局、2025年12月に公表された介護保険部会意見書では、2つ目の住宅型有料老人ホームの入居者を対象にする案が採用され、1つ目の利用者の所得状況を金額に反映させる案と、3つ目の給付管理業務の実費相当分を求める案は見送られた。

2 | 有料化される住宅型の線引きは？

では、2つ目の案では一体、どんな内容が打ち出されているのだろうか。この案を理解する上では、有料老人ホームを巡るケアマネジメントの費用構造を説明する必要がある。

そもそも、有料老人ホームには「一般型」「住宅型」の2つがある。このうち、前者では住まいとサービスの提供が一体化されており、介護保険制度では「特定施設入居者生活介護」というサービスに類型化されている。この類型に入ると、特定施設入居者生活介護の事業者には月額の手当料(いわゆる包括報酬)が支払われるため、どれだけ事業者がサービスを提供しても、要介護度別に決まっている基本的な報酬の水準は原則として変わらない。ケアマネジメントについても、特定施設入居者生活介護の事業者を支払われる報酬に組み込まれている。

これに対し、後者の住宅型では住まいとサービスが分離されており、あくまでも在宅扱いである。このため、利用者に提供される介護サービスの報酬は回数ごとに評価する出来高払いであり、ケアマネジメントとサービス提供に関わる報酬も別々に支払われている。

しかし、いわゆる「囲い込み」の案件については、住宅を運営する事業者とサービスを提供する主体が一致しており、利用者も他の事業者を選べないため、実質的に特定施設入居者生活介護と同じ状況である。

そこで(上)で述べた通り、介護保険部会意見書では、特定施設入居者生活介護との均衡を図る観点に立ち、医療的ニーズの高い人などを受け入れている有料老人ホームについては、報酬を定額払いとするとともに、登録制などの事前規制を導入する考えが示された¹⁵。

さらに、本稿で検討しているケアマネジメントの有料化については、事前規制の対象となる有料老人ホームに関して、ケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する必要性が指摘された。

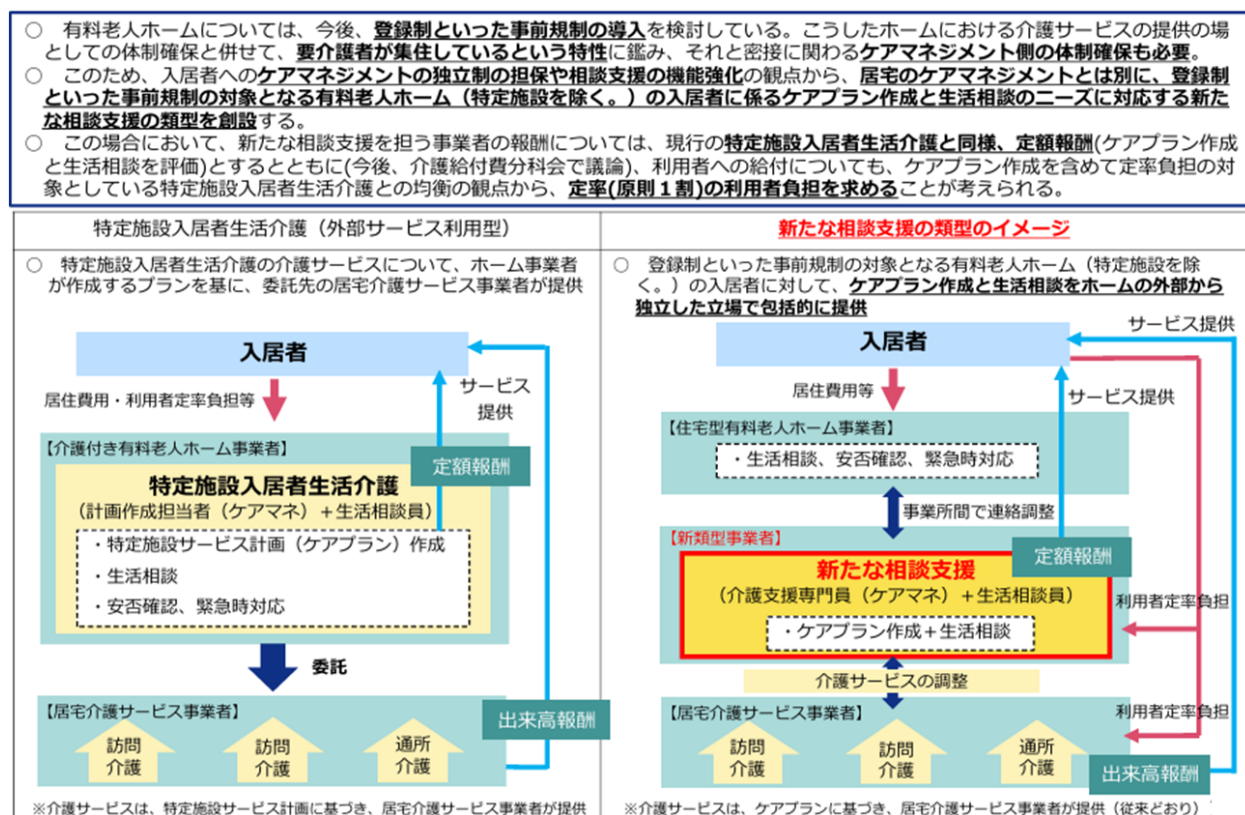
つまり、特定施設入居者生活介護と同じように、住まいとサービスを一体的に提供している住宅型有料老人ホームについては、報酬体系を特定施設入居者生活介護と同じように改めることで、ケアマネジメントを実質的に有料化するというアイデアである。

新しい相談支援の類型について、厚生労働省が示しているイメージは図表8の通りであり、介護保険部会意見書では、2027年度介護報酬改定での決定に向けて、詳細を介護給付費分科会などで議論す

¹⁵ これとは別に、2026年2月に概要が決まった2026年度診療報酬改定では、同一建物に集中的に訪問看護を提供した場合の減算ルールなどが導入された。

るという方向性が示された。今後、2026 年特別国会で関連法改正案が提出されるほか、2026 年 12 月までに介護給付費分科会などで検討が進む見通しだ。

図表8：新たな相談支援のイメージ



出典：厚生労働省資料から抜粋

3 | 業界団体の反応は…

こうした厚生労働省の提案に対し、業界団体の反応は割れている。まず、ケアマネジャーの業界団体である日本介護支援専門員協会は新たなサービス類型と既存のケアマネジメントを「明確に別物」と位置付けた上で、後者の有料化は容認できないと述べている。さらに、有料化論議については、「もう今回で終わらせるべき」「（筆者注：ケアマネジメント全体への有料化の）飛び火、なし崩し的な議論の波及は絶対に認めない」「新タイプのサービスに利用者負担を導入することをもって、ケアマネジメントへの利用者負担導入の議論は終結した」と強い姿勢で臨んでいる¹⁶。

つまり、新たな相談支援の創設と有料化を提案することで、全体のケアマネジメント有料化を回避しつつ、今回の制度改正をケアマネジメント全体の有料化に向けた「蟻の一穴」にせず、住宅型有料老人ホームにとどめるべきだという主張である。そもそも、経緯を振り返ると、新たな相談類型を作る案は元々、2025 年 12 月に自民党のケアマネジメント推進議員連盟の決議や日本介護支援専門員協会の提言¹⁷に盛り込まれていた。中でも、前者ではケアマネジメントに関する現行制度の「堅持」を前

¹⁶ 2026 年 3 月号『日経ヘルスケア』、同年 1 月 8 日『Joint ニュース』配信記事における日本介護支援専門員協会の柴口里則会長に対するインタビューを参照。

¹⁷ 2025 年 12 月 10 日の日本介護支援専門員協会「住宅型有料老人ホーム入居者に対する ケアマネジメントの在り方に関す

提にした上で、住宅型有料老人ホームのケアマネジメントについては、「現場の実態や関係者の意見を十分踏まえつつ丁寧に検討すること」と書かれており、有料化に「反対」と書かれていなかった。

このため、関係者が「既存のケアマネジメントは現行制度を堅持、有料化はやらない」「住宅型有料老人ホームのケアマネジメントだけを取り出す形で、適正化の名目で有料化」という形で足並みを揃えているように映る。

これに対し、高齢者住宅の関係業界からは2つの理由で強い懸念が示されている¹⁸。第1として、現行制度との不整合が指摘されている。つまり、今までは住宅型有料老人ホームについては、介護保険法とは別に生活相談の提供が義務付けられており、利用者は自費で負担している。ここで新類型が誕生し、ケアマネジメントが有料化されると、利用者は二重負担になるというわけだ。

もう一つのリスクについては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが住宅型有料老人ホームの入居者の担当を敬遠する結果、いわゆる「囲い込み」が助長される懸念である。要するに、有料化されると、今まで担当していた地域のケアマネジャーは利用者から費用を徴収するなど負担が増えることになりかねず、結果的に地域のケアマネジャーが担当を忌避するようになり、外部の目が入りにくくなる危険性である。

さらに、利用者がケアプランを自分で作成（いわゆるセルフケアプラン）すれば、利用者負担を回避できるため、住宅型有料老人ホームの事業者が「利用者による自己作成です」と説明しつつ、過剰なサービスをケアプランに入れるような事態も想定されるという趣旨の懸念も示されている。

6——先送りされていた3つの問題の内容（3）～総合事業の対象者拡大～

最後に、総合事業の対象者拡大についての経過である。前の2つと同様、財務省は2025年11月の財政審で、介護1～2を対象者に加えるように改めて主張したが、同年11月の介護保険部会では「引き続き包括的に検討」という考え方が示された。同年12月の介護保険部会意見書でも「総合事業の実施状況が各自治体で様ではなく、移行することは難しいのではないか」「制度の持続性の確保や現役世代の負担軽減に向けて、給付と負担の見直し、給付の重点化や効率化を実行していくことが不可欠」などと賛否両論を併記した上で、「検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括的に検討を行うことが適当である」という文言が盛り込まれた。

この経過について論評すると、結論を出さなかった点では、2割負担の対象者拡大と同じである。しかし、他の2つの案件と異なり、具体的な見直しの提案さえ示されておらず、見直し時期も明示されていない点では、完全な先送りと言える。

7——なぜ先送りされるのか？

以上のような経過を見ると、先送りされていた3つの財政問題については、住宅型有料老人ホーム

る意見」、同月8日の日本ケアマネジメント推進議員連盟「質の高いケアマネジメントの実現に関する決議」を参照。

¹⁸ 2025年12月22日、全国有料老人ホーム協会「介護保険部会における『とりまとめに向けた議論』の『ケアプラン一部有料化』に関する内容と有老協での考え方」のほか、2026年2月10日『シルバーサービス産業新聞』における高齢者住宅協会の木村祐介副会長、全国有料老人ホーム協会の光元兼二事務局次長に対するインタビューを参照。

のケアマネジメントを実質的に有料化するのを除けば、今回も先送りされたと言える。

では、こうした先送りがなぜ続くのか。先送りされた3つの財政問題に共通する背景として、(1) 収斂しない介護保険部会の意見、(2) サービスの特性に関する医療との違い、(3) 介護保険給付費の規模——という3つの点を指摘できると考えている。

まず、1つ目として、介護保険部会における意見が全く収斂しない経緯である。具体的には、保険料負担の抑制を重視する健保連などが制度改正に賛成を示すと、業界団体や利用者代表が難色を示す展開が長く続いている。

第2に、サービス特性に関する医療との違いである。医療の場合、病院や診療所、薬局で検査や治療・手術、服薬などを受ければ、医療サービスを使う必要がなくなる。それでも慢性疾患の人や在宅医療を受ける人、長期入院の患者には継続的な支援が必要だが、医療サービスを毎日、使うことは稀である。

これに対し、介護の場合、リハビリテーションなどで回復可能性を期待できる要支援者などを除けば、サービスを使い始めると、亡くなるまで継続することが多い。このため、一口に「高齢者の負担増」と言っても、医療よりも介護の影響が大きくなる可能性が想定される。実際、過去の政府文書では、こうした介護サービスの特性が指摘されていた¹⁹。

3つ目として、介護の給付抑制額は総じて小さく、厚生労働省から見ると、「費用対効果が悪い」と判断されやすい面も指摘できる。具体的には、医療保険の給付費は約48兆円だが、介護は約11兆円であり、4倍以上の開きがある。このため、小規模な見直しでも医療は一定程度、給付抑制額を捻出できるが、介護の抑制額は小さくなってしまう。こうした状況の下、医療制度改革の議論が先行し、介護の見直しに関する結論が後回しになりやすくなっている。

図表9：補足給付の現状

負担額	補足給付の 主な対象者		預貯金額 ※カッコ内は夫婦
第1段階	生活保護受給者		要件なし
	世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者		1,000万円（2,000万円）以下
第2段階	世帯全員が 市町村民税 非課税	年金収入額＋合計所得金額が80万円以下	650万円（1,650万円）以下
第3段階①		年金収入額＋合計所得金額が80万円超～120万円以下	550万円（1,550万円以下）
第3段階②		年金収入額＋合計所得金額が120万円超	500万円（1,500万円）以下

出典：厚生労働省資料を基に作成

8——その他の案件

今後の展望に入る前に、介護保険部会意見書では3つの財政問題以外にも、制度改正の論点が言及されているので、簡単に触れる。

まず、補足給付については、応能負担を強化する観点に立ち、区分を細分化することが決まった。現在は図表9のような区分になっているが、第3段階①が「80万円超100万円以下の段階（第3段階

¹⁹ 例えば、改革工程では「介護サービスは医療サービスと利用実態が異なること等を考慮」、2022年12月の介護保険部会意見書では「介護サービスは、医療サービスと異なり利用が長期にわたるものなので、費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要」といった文言が入っていた。

①ア)」「100 万円超 120 万円以下の段階（第 3 段階①イ）」、第 3 段階②が「120 万円超 140 万円以下の段階（第 3 段階②ア)」「同 140 万円超の段階（第 3 段階②イ)」に細分化されることになった。

さらに、施設系サービスにおける多床室（いわゆる相部屋）の居住費に関わる利用者負担についても言及があり、引き続き介護給付費分科会で検討する旨が盛り込まれた。この関係では、2005 年度に施設系サービスの居住費を保険給付の対象から外した際、多床室に関しては、食費と光熱費だけが対象外とされた。その後、2015 年度から特養の多床室、2024 年度から介護老人保健施設（以下、老健施設）や介護医療院についても、一部の多床室の室料が給付対象から外れた。

これに対し、財務省は 2025 年 11 月の財政審で、「居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費（室料＋光熱水費）」を追求する観点に立ち、全ての老人保健施設や介護医療院の多床室でも、居住費を対象から外すことを求めた。結局、介護保険部会意見書では前回の制度改正から日が経っていないことを理由に挙げつつ、結論を出さなかった。

さらに、財源問題や制度効率化の関係では、▽介護保険料の納付開始年齢を 40 歳から引き下げる是非を引き続き検討²⁰、▽預貯金など金融資産の保険料負担への反映の検討、▽利用者負担の上限を設定する「高額介護サービス費」の在り方に関して引き続き検討、▽要介護認定の申請を代行できる対象サービスの拡大、▽2024 年度報酬改定で創設された福祉用具の貸与、販売の選択制に関して、販売額を設定、▽介護被保険者証の本人確認手続きの簡素化——といった内容も盛り込まれた。

このほか、高齢者虐待防止に向けた安全性の確保やリスクマネジメントの推進も言及され、市町村は事業所からの報告受付、報告内容の集計・傾向把握、都道府県は報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村の相談対応・助言、広域的な研修、注意喚起、国が事故情報の収集や分析・活用、報告様式の標準化などに取り組む必要性も示された。

9——今後の展望

1 | 今後の見通し

以上のような記述を踏まえ、以下では私見も交えつつ、財政問題を中心に今後の展望を試みたい。先送りされた 3 つの問題のうち、2 割負担の対象者拡大は 2026 年 6～7 月頃に結論が示される見通しだ。さらに、住宅型有料老人ホームに関わるケアマネジメントの有料化は 2027 年度の実施が想定される。

このうち、2 割負担の対象者拡大に関する 2 つの方策のうち、預貯金を考慮する案に関しては、現場の市町村の事務負担を考えると、実質的に困難と思われる。このため、実施するのであれば、上限 7,000 円を設定するという 1 つ目の案ではないか、と推察される。

しかし、高齢者の患者負担見直しが今後、焦点になるとみられ、今までと同様に「給付削減額を多く稼げる医療制度改革を先行させる」と判断される可能性も想定される。

2 つ目のケアマネジメント有料化に関しては、2026 年特別国会での法改正を経て、2027 年度介護報

²⁰ 保険料の納付開始年齢が 40 歳と設定されている理由について、厚生労働省は「被保険者が老化に起因する疾病になり、介護が必要となる可能性が高くなる」「被保険者の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる」という 2 つの点を挙げているが、制度創設時には様々なオプションが検討されており、自民党や財界の意見を踏まえて、現在の姿になった。詳細については、2019 年 2 月 26 日拙稿「[介護保険料の納付開始年齢はなぜ 40 歳なのか](#)」を参照。

酬改定に向けて詳細を詰める流れが想定される。その際には、事前規制を導入する住宅型有料老人ホームの対象の詳しい線引きに加えて、いわゆる「囲い込み」を助長させないような手立ても論点になると思われる。

2 | 介護保険の財政問題の優先順位は低い？

さらに私見を加えると、3つの財政問題について、ズルズルと先送りをするのではなく、一定程度の方向性を示すことも重要と考える。

そもそもの前提に立つと、(下)で触れる介護人材の問題が解消されなければ、介護保険の財政問題は解決に向かうかもしれない。いくらニーズがあっても、介護職員を確保できなければ、サービスが枯渇し、その結果として給付費も伸びなくなるためだ。このため、筆者自身の意見では「介護保険の財政問題の優先順位は低い」と考えている。特に、2割負担の対象者拡大を含む利用者負担の問題に関しては、高齢者医療や年金制度の見直しが複合的に絡むため、この問題だけを切り離して検討することが困難であり、優先順位が下がるのは止むを得ない面がある。

一方、ケアマネジメントの有料化について、財務省の主張は全く論理的とは言えず、この議論に終止符を打つ必要があると考えている。実際、図表7で挙げた財務省の資料は有料化という主張を理屈付けするためのデータが公開されているが、有料化しても解決に繋がるとは考えにくい。

具体的には、財務省は現状の問題点として、「事業者と利用者（家族）でサービスを決めてきて、後からプラン作成だけ依頼された」「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」といったデータとか、住宅や有料老人ホームのケアプラン作成に際してケアプランが画一的というデータを挙げている。こうした実態が存在することは筆者も見聞きしており、当然にして、改善することが求められる。

しかし、これらの問題が起きている背景には「独立したケアマネジャーが少なく、約9割が他のサービス事業所と併設されている」「介護保険サービスをケアプランに組み込まないと報酬を受け取れない」というケアマネジャー、あるいはケアマネジメント（制度的には居宅介護支援費）の構造が影響しており、ケアマネジメントが無料であることと関係しているとは思えない。言い換えると、独立性の問題などを改善しなければ、有料化しても事態は改善しないし、いわゆる「囲い込み」の助長などの事態も懸念される。

総合事業の対象者拡大についても、同様の点を指摘できる。これが実現できない要因としては、事業の趣旨さえ市町村に浸透していない現状があり、論理的に考えれば、今の状況が大きく改善されれば検討できる条件は揃う。

しかし、市町村職員の意識や行動を変えるのは多大な手間暇を要するため、解決は容易ではない²¹。さらに、要介護認定との整合性という大きな問題も横たわる。つまり、そもそも、要支援者は法律上、「状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要する」とされた人であり、予防による状態の

²¹ なお、筆者は「市町村に不可能」と考えているわけではない。地方分権改革から四半世紀を経て、市町村の政策形成能力は高まっていると考えている。しかし、多くの市町村職員は高齢者の暮らしや「地域の実情」を踏まえず、国の通知や方針に沿って、「高齢者が体操などを楽しむ『通いの場』に来る高齢者をどう増やすか」といった形で事業や制度の課題を語っており、こうした思考や行動を変えない限り、総合事業は広がらないと考えている。

改善、あるいは維持が強く意識されているため、予防を重視する総合事業に移管できた。

これに対し、要介護1～2の人は改善可能性を必ずしも想定しておらず、軽度な認知症の人も含まれる。このため、介護予防を通じて状態の改善を図る意義は全否定しないが、総合事業に移行させるのは相当、困難と言わざるを得ない。

以上の点を踏まえると、少なくともケアマネジメントと総合事業に関しては、今回で見直し論議を一旦、打ち止めにした上で、喫緊の課題である人材確保に加えて、[\(上\)](#)で言及した複雑・困難ケースへの対応、「地域の実情」に応じた体制整備に向けた市町村の支援強化²²、さらに人口減少における市町村の機能低下への対応などを真剣に検討することが欠かせない。しかも、これらの論点については、クリアカットな解決策が存在せず、地道な検討と現場での試行錯誤が必要になる。

このため、今後の制度改正論議では、堂々巡りが続く財政問題に時間を割くのではなく、こうした難題にエネルギーを注ぐことが求められる。

10—おわりに

本稿では2025年12月の介護保険部会意見書のうち、財政問題を中心に経緯や内容を考察した。これまで結論を先送りし続けた3つの財政問題について、一定程度の方向性が示されたものの、2割負担の対象者拡大は結論が先送りされており、2026年6～7月頃に一定程度の方向性が示されると思われる。さらに、ケアマネジメントの有料化では、住宅型有料老人ホームでの有料化が決まり、2026年特別国会での法案審議と2027年度報酬改定に向けた検討が注目される。

しかし、在宅のケアマネジメントの有料化や総合事業の対象者拡大については、今回も結論が先送りされた。これまでの検討経過や現場の状況などから考えると、財務省の主張を受け入れることは困難であり、議論は今回で打ち止めにする必要がある。

むしろ、介護保険の財政問題の優先順位は低く、人材を確保できなければサービスが枯渇し、財政問題が自然に解消する可能性さえ想定される。このため、堂々巡りの議論で時間を空費するのではなく、人材確保の問題などを検討する必要がある。

(下)では同じ時期に示された福祉部会の意見書にも言及しつつ、2つの報告書に共通している人材確保の問題を論じる。さらに、分野・属性を問わずに支援する「重層的支援体制整備事業」が後景に退いた点や、身寄りのない高齢者支援に関する新たな事業などにも触れる。

²² 近年の医療・福祉に関わる制度改正に関して、「地域の実情」という言葉が政府文書で多用されており、自治体の主体性が期待されている。本稿が取り上げている介護保険部会意見書でも、小見出しや参考資料を含めて、20回以上使われている。この関係では、自治体に求められる対応などを取り上げたコラムを2023年3月から2025年3月まで計7回連載した（うち1回は番外編）。全7回の[リンク先](#)を参照。